

7. 구토

• 중요 포인트

- 1. 구토는 체액 부족 산/염기 및 전해질 장애를 일으킴
- 2. 병력청취: 1)소화(염증/암/폐색) + 2)신경(뇌출혈, 뇌수막염, BPPV) ± 3)여성(신경성 식욕부진, 임신) 감별
- 3. 환자가 누워서 시작하는 경우 존재 -> 문 들어가자마자 의자를 끌어서 환자분 눈높이 맞게 앉고 손 닦고 v/s 확인하며 시작
- 4. 신체진찰에서의 감별) 구토하는 상황에서 복통/압통은 다 호소 가능 -> 이걸로 감별할 필요 없음
단, 폐색이 있다면 압통은 무조건, 교액까지 있으면 반동압통도 있다고 기억
+ 그 외에는 탈수 확인해서 입원 & 수액 IV or just 경구 수액 요법 선택

• 평가 목표

원인			
소화기		위장관 폐색, 위식도 역류, 소화성 궤양(위염), 위암 감염: 식중독, 급성 위장염, 급성 담낭염 (소아 - 날문 협착증, 장중첩증)	
뇌신경		양성돌발 체위 현기증, 뇌수막염, 뇌출혈 정신: 신경성 폭식증, 신경성 식욕부전증	
기타		요독증, 임신, 심인성 구토	
평가목표			
1) 구토의 정도와 동반된 체액이나 산/염기 및 전해질 장애를 확인하고, 응급조치를 할 수 있는가 2) 원인에 따른 치료계획을 설명할 수 있는가			
구체적인 성과			
병력 청취	위배출 지연/소화기 질환 구별		위배출 지연: 대량/소화안된지 오래된 음식/악취 등의 양상 소화기 질환: 동반되는 소화기 Sx 존재 (A/N/V/C/D/속쓰림/소화불량 등) + 담즙(초록색), 피(커피색, 선홍색), 위액(투명, 노란색) 등의 양상도 체크
	소화기계 이외의 원인 감별		신경계(분출구토), 전정기관(멀미), 기타(임신, 요독증)
	구토와 동반된 체액부족이나 산/염기 및 전해질 장애 평가		탈수 정도: 두근거림/어지러움/호흡곤란/소변량감소 전해질/산염기: 전신 무력감, 근육 경련, 감각 이상 -> 잦은 구토로 인한 산/전해질 소실 의심
신체 진찰	응급 처치가 필요한 체액감소와 산/염기 및 전해질 장애를 평가하기 위한 신체진찰		V/S 확인: 혈압 저하(저혈압), 맥박 상승(빈맥) 혀와 구강 점막의 건조도(Dry tongue/mucosa) 및 피부 탄력성(Skin turgor) 저하 의식 상태: 전해질 불균형이나 뇌 관류 저하로 인한 의식 혼탁 여부 확인 + 증상에 따라 신경학적 검사가 필요: 사지 근력 저하, 감각 이상
	소화기계 폐색을 감별하기 위한 신체진찰		복부 팽만, 이전 수술 흉터(장유착/장폐색 단서) 장음 소실 혹은 금속성 장음, Td/rTd(복막 자극 징후) + Succussion splash: 상복부 흔들었을 때 출렁거리는 소리
	소화기계 이외의 원인을 감별하기 위한 신체진찰		신경계: 수막자극징후, 뇌신경 검사 전정기관: Nystagmus, Dix-Hallpike maneuver 정신: 치아부식, 손의 상처
진단 및 치료	산/염기 및 전해질 불균형 + 체액 부족		혈액검사 (ABGA, 전해질 수치, BUN/Cr) 수액요법 금식 및 안정
	원인 질환 감별	감염	대변배양검사 충분한 휴식 식사 전 손씻기 + 음식가려먹기
		소화기 질환	위내시경, 요소날숨검사 위산 줄여 염증 줄이는 약물
		소화기 폐색 + 암	복부 영상 검사 (xray, CT) 비위관 - 수술 (종양) 병기에 따른 치료
환자 교육	체액, 산/염기 및 전해질 교정의 필요성		수분 부족은 탈수와 어지럼증, 심하면 실신을 유발 전해질 수치가 불균형해지면 근육 경련이나 부정맥 등의 합병증 가능성

	구토에 따른 합병증 예방법	구토 후 탈수 증상 시 입원 후 수액 치료 두통, 팔다리 힘빠짐, 의식 떨어지는 등 신경 Sx 시 내원
	소화기 질환	당분간은 금식 증상이 나아지면 미음이나 죽처럼 부드러운 음식부터 시작 기름지고 자극적인 음식 피하기 식후 눕지 않기, 잘 때 머리부분을 높여서 역류증상이 발생하지 않도록 교육

● 원인 질환 정리

질환		질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
감염	식중독 급성 위장염 1+2	음식 섭취로 인해 바이러스나 세균이 위장을 자극	발열, 복통, 설사, 탈수 상한 음식물 섭취, 같은 먹은 사람도 증상 호소	복부 압통 장음 항진	CBC 전해질검사 대변배양검사	수액 공급 (세균) 경험적 항생제
	급성 담낭염	담낭이 막혀 염증이 발생	복통, 발열, 소화불량, 식후 악화	복통 Murphy's sign	복부 CT, 복부 초음파 LFT	담낭절제술 항생제, 배액
소화	소화성 궤양/위염 1/1	위산에 의해 점막이 헐어 상처/위 점막에 염증	속쓰림, 복통, 신물올라옴 GU) 흑색변, 식후 악화 DU) 식전 악화	복통	위내시경 요소날숨검사 신속요소분해효소검사	PPI 제산제 위점막보호제
	위암 0+1	위에 생긴 종양, 음식 통로를 막거나 자극	빈혈, 체중감소, 흑색변	복통 림프절비대	위내시경 복부 CT	위절제술 내시경 점막하절제술
	장폐색증 4	장이 막혀, 가스와 음식물이 통과하지 못하고 정체된 상태	식후 복통, 복부 수술력, 구토(대량, 소화 X 음식물) +) 약물로 인한 유문부 폐쇄 +) DU 로 인한 유문부 폐쇄	장음 항진 없음?	복부 X-ray	비위관 삽입 전해질 교정 수술
신경	양성돌발 체위현기 증	귀 안의 균형잡는 작은 돌이 벗어나서 움직임	어지럼증, 메스꺼움	Dix-Hallpike test	Dix-Hallpike test	Epley maneuver
	뇌수막염	뇌막에 염증이 생겨 뇌압 상승	두통, 발열, 경부강직	수막자극징후	뇌척수액천자(IICP 주의) 뇌 CT	항생제/항바이러스제, 스테로이드
	뇌출혈	뇌에 피가 고여 압력이 올라감	극심한 두통, 의식저하, 분출구토, 고혈압, CVD, 두부외상 과거력	수막자극징후, 국소 신경학적 이상	뇌 CT 뇌척수액천자	HTN 관리 개두술 및 혈종제거술
정신	신경성 폭식증/식 욕부진증	심리적 문제로 과식/거식이 생기고 그로 인해 위가 자극받음	젊은 여성 고의성 체중/체형에 대한 강박	손에 상처 치아 손상		인지행동치료 SSRI 영양 보충
기타	임신 0+1		가임기 여성 최근 생리 X	골반 진찰	소변 hCG 골반초음파	산전 진찰 안내
	요독증	신기능 저하로 노폐물이 혈액에 쌓여 뇌와 위장관 자극	피로, 거품뇨, 핏뇨, 만성 신부전 병력, 가려움증		serum BUN/Cr 소변검사 신장초음파	신대체요법 신장 이식
소아	날문협착 증	위에서 장으로 내려가는 길이 좁아져 폐색	생후 2~3 주 토하고 자주 먹으려함 분출성/담즙 X		복부초음파	전해질교정 날문근절개술
	장중첩증	장이 안으로 말려들어가 막힘	생후 3~12 개월 심한 복통 딸기잼 같은 변	복통 복부종괴	복부초음파	공기정복술 + 응급수술

O	언제	cf. 장폐색, 식중독/위장관염은 급성(어제, 몇시간 전) // 몇주 됐으면 위장관염/궤양/종양
L	당시 어떤 상황	r/o 식중독(상한음식), 담낭염(기름진음식), 뇌출혈(외상) 등등..
D	자주 / 몇번	
Co	처음보다 심해지나요?	
Ex	이전 경험 - 치료	
C		소량: 위염, 조기 위암, 단순 소화불량. 대량: 위배출구 폐색(기능/구조), 유문협착증 초록색(담즙): 십이지장 아래 문제 선홍색: 말로리-바이스, 식도정맥류 파열 커피색: 소화성 궤양, 위암. (산에 의해 피가 변색됨) 투명/노란색: 위액 (단순 위염, 공복 구토). 먹은 음식이 그대로: 식도 질환 소화 안 된 지 오래된 음식: 위배출구 폐색(기능/구조) 분출성 구토: 두개내압상승 (뇌수막염, 뇌출혈) 신맛 : GERD, 위장관염/궤양 쓴맛(담즙 역류) : 십이지장 아래 문제 악취: 위배출구 폐색(기능/구조) 양상) 양 / 색(담즙, 피) / 덩어리 (음식물) / 냄새 맛(신맛 - 상부, 쓴맛 - 하부, 대변같은 - 장폐색) / 분출성(r/o IICP) 정도) 일상생활에 지장 (-> 공감 PPI) Cf) 우측에 감별하는거 너무 집착해서 알필요 없을 듯
A		전신) 발열/오한/체중변화/피로 r/o 암 응급/탈수) 두근거림/어지러움/호흡곤란/소변량감소/근육경련 소화) 1 N/V/A /복통/명치통/속쓰림/소화불량 2 변비/설사, 혈변/흑색변/지방변 r/o 식중독(설사), 심한복통(장폐색) 신경) 어지럼 /두통/팔다리힘빠짐/ 목뻣뻣 r/o 뇌출혈, 뇌수막염 어지럼/이명 r/o BPPV 정신) 고의적 구토 / PPI + 스스로의 체형 r/o 신경성 식욕부진증 or 폭식증 비뇨) 거품뇨? r/o 요독증
F		[식중독] - 음식 -> 같이 먹은 사람은? - 여행력: 여행가서 안 먹던 음식 - 같이 먹은 사람은? - 과식/과음
E		마지막 건강검진? (위/대장내시경) 간염예방접종
외		수술받은 적이 있나요? (특히 복부) r/o 급성 장폐색 머리 다친 적 있나요?
과		현재 앓고 계신 질환이 있나요? 기본 : 고혈압/당뇨/고지혈증/결핵/간/신 콩팥병 r/o 요독증
약		복용중인 약물? NSAID 진통제 > 얼마나 먹었는지 r/o 소화성 궤양 항구토제
사		기본 : 음주/흡연/커피/직업/스트레스 [식습관] 평소 식사 규칙적? 기름지고 자극적인 음식 좋아하나요? 식후에 곧바로 눕나요? [운동] 운동 규칙적으로 하시나요? 일주일에 몇번 정도 하세요?
가		소화) 소화기질환 / 암 신경) 만성질환 / 뇌졸중
여		LMP, 주기(규칙적), 임신 가능성
PEX		동의 구하기 손 씻기

	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈: 빈혈, 황달 2 입: 탈수 + 치아부식(손가락으로 구토를 유도한 흔적?) r/o 신경성 식욕부진 3 목: 경부 림프절 r/o 암 4 사지 : 피부 긴장도, 손 상처 r/o 신경성 식욕부진 다리부종	
	복부	① 복부: 시-청 (1 군데 당 3-5 초)-타 (먼 곳부터)-촉(먼 곳부터) **환자 수치심이 들지 않도록 잘 설명, 가려주기 3————간 진찰: 타진 (간, 복수) —촉진 (간, murphy)	
	(신경계 의심시) 신경	[뇌신경] 1 동공반사 2 안구운동검사: 제 코 보세요+턱 잡고 좀 천천히 8 방향 3 감각 검사: 눈 감고 검사!! 2 가지(촉각+통증) – 느껴지시나요+동일한가요 4 운동검사 : 눈 꼭 감아보세요 -> 눈 벌려지나 만져보기 이 꼭 깨물어보세요 -> 턱근육 만져보기 +) 볼뽕뽕/ 이 해보세용/ 이마 주름 만들어보세용 [사지] 운동/감각 [수막자극징후]	
PPI	협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기		
진단 및 치료	기본!! + 여성	혈액검사 염증과 전해질 수치, 대사 이상 확인 임신반응검사	수액요법 탈수 예방, 전해질 균형을 위한 수분 공급, 금식 및 안정
	식중독, 급성 위장염	대변배양검사 원인균 파악	충분한 휴식 식사 전 손씻기+음식가려먹기 (검사 결과 필요하다면 anti. 대부분의 경우 필요없다)
	위염, 위/십이지장 궤양 GERD	위내시경, 요소날숨검사 헬리코박터균 확인	위산 줄여 염증 줄이는 약물 (양성자 펌프 억제제, 위점막보호/제산제)
	종양, 장폐색증	복부 영상 검사 (xray, CT) 원인 파악 - 폐쇄 위치, 기계적/마비적 장폐색	비위관(감압) – 수술 장이 막혀 음식물이 못 내려감 코로 관을 넣어 위·장 비우기 심해질시 (교액,복막염 의심시) 수술적 치료 (종양) 병기에 따른 치료
교육	생활습관 교정 (안심/회피,교정/검진접종/응급) [안심] 특별한 합병증 없이 치유되는 경우 대부분! [회피] 고지방식/소화안되는 음식은 구토 유발 요인이니 가급적 피하기 [응급] 1) 구토 후 탈수증상 또는 전해질 이상으로 인해 호흡곤란, 어지러움, 근육 경련, 등 응급상황이 생길 수 있다고 교육 -> 입원 및 수액 치료 받기 위해 병원 오라고 교육 2) 두통, 팔다리 힘빠짐, 의식 떨어지는 등 신경 Sx.시 내원 [항구토제] 일시적 증상완화, 가급적 사용 X 부작용: 변비/설사/피로/두통 + 구토 근본 원인 가려 치료 늦어질 수		
PPI	오늘 검사 및 수액치료할 시간 괜찮으신지? 궁금하신 점 있으실까요?		

🎨그림으로 시작하는 CPX

1) V/S check 응답확인

2) 탈수경향 : 호흡곤란
어지럼

두근거림
갈증



☆기본
: 복부시정타동
DRE

임진왜란

Nice2헬프 🙌

ㄴㅇㄹ 장테세 33

BPPV
Dix-Hallpike

에너지 전환
고효율, 친환경

가정



산형성악부원



맘친

임상능력
양호